Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível do Foro Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 14º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110-230 - Fone: (51) 321-06500 - Balcão virtual: (51) 98010.4411 - Email: frpoareg4d2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000232-32.2024.8.21.1001/RS

AUTOR: IVANA IARONKA

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos.

IVANA IARONKA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO ORDINÁRIA** em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, tendo sido diagnosticada com Cancer de Mama, estágio clínico III. Em face do aludido quadro clínico, foi prescrito à autora, dentre outros medicamentos, o uso do medicamento Abemaciclibe 150 mg via oral 12/12 horas, por 2 anos, tendo a requerida, no entanto, negado a fornecer o aludido medicamento sob a argumentação que o plano de saúde havido não possuiria tal cobertura. Teceu considerações acerca da incidência do CDC ao feito em comento e da abusividade da cobertura postulada, requerendo, liminarmente, o fornecimento da aludida medicação e, ao final, que a requerida fosse compelida a fornecer o postulado tratamento médico. Requereu a AJG e juntou documentos (evento 1).

Deferida a AJG, restou igualmente deferida a liminar pleiteada (evento 3).

Citada, a requerida apresentou contestação impugnando o valor da causa e alegando, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura. Destacou, ainda, que o tratamento reclamado não estaria no rol da ANS, requerendo, ao final, a improcedência dos pleitos autorais e juntou documentos (evento 11).

Houve réplica (evento 17).

Prolatado despacho saneador e instadas as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas (evento 31), ambas postularam o julgamento antecipado da lide (eventos 36 e 37).

Vieram-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **IVANA IARONKA** em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL** em que entendo cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que, além da desnecessidade de produção de prova em audiência, as partes, embora devidamente intimadas para tanto, não postularam a produção de outras provas.

Inexistem preliminares pendentes de análise, razão pela qual passo, diretamente, ao julgamento do mérito da ação.

Sinalo, ainda num primeiro momento, que a relação que se operou entre as partes é nitidamente consumerista, estando tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o contrato firmado entre as partes visa a prestação de serviços, prevista pelo artigo 3º, § 2º, do CDC.

Acerca do tema, transcrevo a brilhante lição de Cláudia Lima Marques, na obra Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, *in verbis*:

> *"Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor. Note-se que o destinatário do prêmio pode ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, que participará como beneficiária do seguro.*
>
> *Nos dois casos, há um destinatário final do serviço prestado pela empresa seguradora. Como vimos, mesmo no caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado por especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço ou preposto), há a presença do 'consumidor' ou alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e seu parágrafo único.*
>
> *Portanto, os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas cláusulas estarem de acordo com tal diploma legal, devendo ser respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento ao consumidor do conteúdo do contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor."*

Desta forma, tenho que a interpretação das cláusulas do contrato havido entre as partes deverá ser efetuada à luz da Lei Consumerista, em especial por se tratar de um "contrato coletivo por adesão", impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais do aludido contrato da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Nesta senda, corroborando meu entendimento, colaciono a jurisprudência do STJ:

"AÇÕES COMINATÓRIA, INDENIZAÇÃO E CAUTELAR. CONTRATO DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR (SEGURO-SAÚDE). CLÁUSULA LIMITATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO ADERENTE. O reexame do conjunto probatório e a exegese de cláusulas contratuais são tarefas imunes ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, consoante a orientação sumulada nos verbetes ns. 5 e 7. Estabelecida a premissa acerca da dubiedade da cláusula inserta em contrato de adesão, deve ela ser interpretada a favor do aderente. Ajuste do dano moral aos valores usualmente fixados pela Corte. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (REsp435241 / SP RECURSO ESPECIAL 2002/0055508-3)".

Destaco, por oportuno, que o próprio STJ possui entendimento sedimentado que ao fornecedor dos planos de saúde caberá, apenas, estabelecer qual o alcance dos planos de saúde ofertados, elencando quais as doenças abrangidas e quais as doenças excluídas por estes, não cabendo, porém, limitar o tipo de tratamento coberto por cada plano, decisão, esta, que caberá apenas e unicamente ao médico do paciente, *expert* no assunto, restando afastada, desta forma, a alegação da parte demandada de ausência de cobertura pela alegada ausência de previsão do tratamento no rol da ANS.

Nesse sentido, por entender pertinente e ante a similitude dos feitos, colaciono a decisão da Superior Instância:

"AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. [...] IV. De outro lado, a autora pretende ver reconhecida a obrigação da ré em custear o exame de ressonância magnética, cuja cobertura foi negada. V. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. VI. Outrossim, embora a contratação original tenha sido anterior à entrada em vigor da Lei n° 9.656/98, tal diploma legal é perfeitamente aplicável à situação dos autos, haja vista que o contrato de plano de saúde, por ser de trato sucessivo, renova-se anual e automaticamente. VII. Portanto, mostra-se abusiva a cláusula contratual que embasa a negativa de cobertura para a realização do exame [...] APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70071313019, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)".

No caso em comento, inexiste no contrato havido entre as partes qualquer cláusula excluindo a cobertura da doença que acometeu a autora (Adenocarcinoma de pulmão, metástases pleurais, ósseas e linfonodais), o que, ao fim e ao cabo, torna forçoso reconhecer a abusividade da negativa de cobertura realizada pela requerida.

Consigno, ainda, que, consoante decisão da Superior Instância prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 5045938-83.2024.8.21.7000/TJRS que ora também adoto como razão de decidir, a própria Lei nº 9.656/98 consignou, no seu artigo 12, a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos antineoplásicos, bem como a possibilidade de utilização do medicamento ainda que de forma *off label*, *in verbis:*

No caos dos autos, trata-se de pedido de fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg, para tratamento da doença que acomete a autora, ora agravada: Câncer de Mama, estágio clínico III.

A operadora do plano de saúde negou cobertura do medicamento postulado sob a justificativa de que *" A autorização da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, nos termos da Resolução Normativa - RN 465 (art. 3º, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, o que no caso não ocorre, pois o medicamento Ademaciclibe, solicitado para o tratamento adjuvante de câncer de mama (T2, N1, M0), consta na lista dos medicamentos cobertos pela referida Diretriz de Utilização, porém, para o tratamento de pacientes com câncer de mama avançado ou metastático".*

No caso dos autos, devem ser observadas de modo prioritário as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, observado o disposto na Lei nº 9.656/98, nos seguintes termos, *in verbis*:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> *(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *[...]*
> *§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *[...]*
>
> *§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. [grifei]*

Neste norte, tem-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS possui a função de garantir e publicizar o direito dos beneficiários dos planos de saúde, abrangendo os tratamentos, procedimentos e medicamentos considerados indispensáveis, seja ao diagnóstico ou à cura da enfermidade.

Ainda, considerando a pluralidade de entendimento da jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adotava posição de que o rol da ANS era meramente exemplificativo, - a contrário do que entendia a Quarta Turma -, a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1886929 e REsp 1889704, por maioria de votos, concluiu **ser taxativo, de regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS,** não podendo ser exigidos das operadoras de plano de saúde, portanto, a cobertura dos tratamentos ali não previstos.

Já para as situações excepcionais, o STJ definiu **critérios** para os quais os planos de saúde deverão custear procedimentos não previstos na lista, senão vejamos:

> *1) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;*
>
> *2) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*
>
> *3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
>
> *4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que*
>
> - *(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar;*
> - *(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;*
> - *(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e*
> - *(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*

Inobstante a isso, em 21 de setembro de 2022, a **Lei nº 14.454/2022** instituiu parâmetros para que fosse possibilitada a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estivessem incluídos no rol da ANS, assim concluindo:

> *"§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*** ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*** ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - **existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*** ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)"***

No que se refere aos medicamentos de uso domiciliar, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, elencou somente os medicamentos antineoplásicos dentre as coberturas obrigatórias, incluídos aí os medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

Ilustro:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

*c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*** ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)*** *[grifei]*

Por fim, a alegação de que a negativa de cobertura teve por fundamento o uso *off label* (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), deve igualmente ser afastada no caso concreto.

Nesse particular, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza *off label*, conforme se extrai do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.
USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).
3. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido".
(AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Com efeito, esta Câmara adota o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui, em regra, natureza taxativa, exceto, dentre outras situações, o fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, **como no presente caso:**

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIAMENTO. NEOPLASIA DE MAMA. COBERTURA. ABEMACICLIBE 150 MG. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.** Caso em que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois comprovada a probabilidade do direito invocado e, ainda, a urgência no atendimento do pleito, pois demonstrada a moléstia que acomete a parte autora da ação, inclusive, com grave risco de vida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53435688520238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-02-2024)*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE REGULAMENTADO. MEDICAMENTO ABEMACICLIBE. ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. DEVER DE COBERTURA DE TRATAMENTO.** MULTA DIÁRIA. 1. O contrato do plano de saúde é regulamentado pela Lei nº 9.656/98, sujeitando-se, ainda que de forma subsidiária, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, consoante verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As coberturas são aquelas definidas na Resolução Normativa nº 465/01, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98. 3. A orientação jurisprudencial atual é no sentido de que o tratamento antineoplásico possui cobertura abrangente, sendo despiciendo, portanto, o fato de não estar prevista especificamente para a patologia que acomete o paciente. 4. Ademais, o medicamento se encontra com o seu registro válido na Anvisa, além de haver várias notas técnicas do e-NatJus informando a eficácia do uso do Abemaciclibe para câncer de mama com expressão positiva de receptores hormonais. Outrossim, o medicamento mostra-se imprescindível à manutenção da saúde do beneficiário, acometido de doença grave e com risco de rápida evolução da doença. 5. A multa diária deve ser compatibilizada com a natureza da obrigação e a urgência do cumprimento da medida, nos termos do art. 537 do CPC, tendo por escopo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo em vista a urgência da medida, e somente haverá sua incidência caso haja o descumprimento. No caso, contudo a parte agravante informou o pronto cumprimento da decisão do juízo, sendo cabível manter, por ora, o valor fixado pelo juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 52408536920238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-10-2023)*

Note-se, ainda, que a autora logrou comprovar por meio dos laudos e exames que acompanharam a exordial (evento 1) tanto a existência de indicação pelo seu médico de confiança do uso do medicamento Abemaciclibe 150 mg via oral 12/12 horas, quanto a efetiva necessidade do reclamado medicamento, impondo-se, deste modo, a confirmação da liminar anteriormente deferida por este Juízo e o acolhimento do pleito autoral inicialmente formulado.

POSTO ISSO, JULGO **PROCEDENTE** o pedido inicialmente formulado na presente **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **IVANA IARONKA** em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL** a fim de, CONFIRMANDO a liminar anteriormente deferida por este Juízo, reconhecer a obrigação da requerida em fornecer, por 2 anos, o medicamento Abemaciclibe 150 mg via oral 12/12 horas, nos termos requeridos na exordial.

Condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios em favor da parte autora que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ora arbitro em R$ 2.500,00.

Em face da nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º do NCPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Oportunamente, com o trânsito em julgado da presente decisão e no silêncio das partes, arquive-se o feito com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LAÉRCIO LUIZ SULCZINSKI, Juiz de Direito**, em 2/10/2024, às 16:2:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10068952211v4** e o código CRC **1a3cb177**.